IMSS

Dirección de Prestaciones Médicas

Coordinación de Proyectos Especiales en salud

Guía Operativa para la Respuesta ante Saldo Masivo de Víctimas (SMV) en Establecimientos de Salud del IMSS

Índice

Directorio 3
1. Objetivos, alcance y definiciones 5
2. Principios generales de actuación 6
3. Aspectos clave en cada fase ante un incidente con SMV 7
3.1 Criterios operacionales de activación 7
3.2 Acciones durante la fase de preparación y alistamiento 7
3.3 Actividades durante la respuesta 8
3.4 Actividades para la fase de recuperación y restablecimiento de las funciones operativas habituales 9
4. Procedimiento operativo 9
5. Anexos 14
Anexo 1. Grado de activación de recursos ante un SMV 14
Anexo 2. Listado de establecimientos de apoyo (RISS) 15
Anexo 3. Identificación de áreas de expansión en el hospital 15
Anexo 4. Diagrama de flujo de la respuesta ante Saldo Masivo de Víctimas 16
Referencias 16
Recursos 21
Contacto 22

Directorio

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto
Dirección General

Dr. Jorge Gaviño Ambriz
Secretaría General

Dra. Alva Alejandra Santos Carrillo
Dirección de Prestaciones Médicas

Dr. Mauricio Hernández Ávila
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Mtro. Borsalino González Andrade
Dirección de Administración

Lic. Luisa Obrador Garrido Cuesta
Dirección de Incorporación y Recaudación

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda
Dirección Jurídica

Mtra. Claudia Laura Vázquez Espinoza
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Mtro. Marco Aurelio Ramírez Corzo
Dirección de Finanzas

Lic. Javier Guerrero García
Dirección de Operación y Evaluación

Mtro. Arturo De Lucio Ortega
Dirección de Planeación para la Transformación Institucional

Dra. Janett Alvarado González
Coordinación de Proyectos Especiales en Salud

Este documento fue elaborado por la **Coordinación de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS** e incorpora recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y mejores prácticas basadas en la evidencia sobre gestión de emergencias en salud y la atención de incidentes con múltiples víctimas.

Este documento está alineado con lo establecido en los ítems 120 a 123, 140, 142, 143 y 146 de la lista de verificación del Índice de Seguridad Hospitalaria de la Organización Panamericana de la Salud.

Es responsabilidad de cada establecimiento de salud adaptar las recomendaciones aquí vertidas, considerando sus capacidades, recursos, nivel de atención, análisis de riesgos y condiciones particulares, bajo el criterio técnico y profesional del personal responsable, priorizando la seguridad de pacientes, personal y la continuidad de los servicios.

Derechos reservados © 2026
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos patrimoniales.

1. Objetivos, alcance y definiciones

Objetivo General

Homologar la respuesta de los establecimientos de salud del IMSS ante un Saldo Masivo de Víctimas (SMV) de cualquier origen (multiamenaza), a través de identificar los elementos clave de preparación, alistamiento, respuesta y vuelta a la normalidad.

Ámbito de aplicación

Esta guía aplica a los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención.

Que pueden actuar como:

- Unidad de choque (puerta de entrada y filtro principal de víctimas),
- Unidad de apoyo (desahogo y redistribución de pacientes) y/o
- Unidad insignia (mayor capacidad resolutiva especializada).

Alcance

El presente documento está dirigido al personal directivo y a los integrantes del Comité de Emergencias y Desastres de los Establecimientos de Salud, responsables de áreas críticas (urgencias, terapia intensiva, quirófanos, hospitalización, laboratorio, imagenología, entre otros), quienes participan en el desarrollo de implementación de Planes de Respuesta, y todo el personal que participa durante la atención en emergencias y desastres en las unidades médicas

Definiciones clave

- **Saldo Masivo de Víctimas (SMV):** Evento que genera un número elevado de pacientes en un periodo corto de tiempo, consumiendo rápidamente los recursos disponibles y requiriendo medidas extraordinarias de organización, expansión de capacidades y apoyo externo.
- **Unidad médica de choque:** Establecimiento que recibe inicialmente la mayor parte de las víctimas y funciona como filtro para triage y distribución hacia otros hospitales de la Red Integrada de Servicios de Salud.
- **Unidad insignia:** Hospital con alta capacidad resolutiva para el tipo de lesiones predominantes (trauma, quemados, infecciosas, etc.) que concentra los casos más graves y complejos.
- **Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS):** Conjunto organizado de establecimientos de distinta complejidad que prestan servicios integrados a una población definida y comparten responsabilidad por los resultados de salud.

- **Puesto de Mando (PM) / Comité del Establecimiento en Emergencias y Desastres:** Estructura de coordinación que dirige la respuesta, distribuye recursos, establece prioridades y mantiene la comunicación con el nivel táctico y estratégico.
- **Noria de ambulancias:** Circuito vehicular unidireccional para entrada, maniobra, desembarque, reabastecimiento y salida de ambulancias, destinado a evitar congestión y facilitar el flujo continuo de pacientes.
- **Binomio médico-enfermería:** Unidad básica de atención clínica para triage, estabilización y traslado intrahospitalario de cada paciente durante un SMV.
- **Triage hospitalario:** Proceso sistemático de clasificación rápida de pacientes en el hospital según su gravedad y recursos disponibles, utilizando escalas como START o SIEVE para priorizar atención en SMV.

2. Principios generales de actuación

1. **Seguridad del personal y de los pacientes.** Ningún paciente se beneficia si el personal se convierte en víctima. El acceso a áreas inseguras, contaminadas o con riesgo estructural solo se realizará tras confirmación de seguridad y con EPP adecuado.
2. **Mando único y Sistema de Comando de Incidentes para Establecimientos de Salud (SCI-H).** La gestión de un SMV se hará mediante una estructura de mando clara (PM/COE hospitalario), con funciones definidas (operaciones, logística, administración/finanzas, comunicaciones y seguridad), alineada al SCI-H y a los COE/Centro Reguladore de Urgencias Médicas (CRUM) externos.
3. **Continuidad operativa del establecimiento.** El objetivo no es solo atender a las víctimas del SMV, sino evitar el colapso funcional del hospital, preservando áreas y servicios críticos (urgencias, UCI, quirófanos, banco de sangre, imagenología, sistemas de información, suministros energéticos y medicinales).
4. **Triage.**
   Uso de sistemas de triage prehospitalario y hospitalario reconocidos, con adaptación para SMV (colores/ niveles).
5. **Modelo de atención por binomios médico–enfermería.** La célula básica de atención en un SMV es el binomio médico–enfermería, que acompaña al paciente desde triage hasta su destino final (área roja/naranja/amarilla/verde, sector negro, referencia o egreso).
6. **Expansión de capacidades y reconversión escalonada.** Suspender actividades no críticas, liberar camas, habilitar áreas de expansión y reconvertir temporalmente espacios para aumentar la capacidad de atención.

7. **Conformación de la RISS.** Ningún hospital debe responder de forma aislada. La unidad médica de choque, la unidad médica insignia y las unidades médicas de apoyo deben coordinarse a través de un sistema de regulación y referencia-contra referencia, evitando la saturación y mejorando la probabilidad de sobrevida.
8. **Atención a grupos en situación de vulnerabilidad.** Considerar flujos específicos para niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas embarazadas, personas con discapacidad y personas con barreras de comunicación o movilidad, así como aquellas con condiciones de salud mental preexistentes o con mayor riesgo de afectación psicológica
9. **Comunicación clara, oficial y en lenguaje sencillo.**
   - Mensajes internos y externos alineados a la operación.
   - Un solo vocero institucional para medios.
   - Información oportuna y respetuosa para familias, cuidando confidencialidad y protección de datos.
10. **Apoyo psicosocial y bienestar del personal.** Debe contemplarse desde el inicio la presencia de equipos de apoyo psicosocial para víctimas, familiares y personal de salud, incluyendo primeros auxilios psicológicos, estrategias de relevos, descanso, alimentación, manejo de estrés agudo y detección temprana de reacciones psicológicas severas.
11. La seguridad física y psicológica del personal de salud es prioritaria, considere que las medidas de protección de la salud mental ayudan a prevenir fatiga extrema, errores asociados al estrés y ausentismo.
12. **Aprendizaje y mejora continua.** Todo SMV real o ejercicio debe generar un informe posterior con lecciones aprendidas y plan de mejora, retroalimentando planes, procedimientos y entrenamiento.
13. **Enfoque inclusivo y equitativo**. Atención no diferenciada a todas las personas afectadas, con respeto a la diversidad y aplicación de protocolos específicos para grupos vulnerables.

3. Aspectos clave en cada fase ante un incidente con SMV

3.1 Acciones durante la fase de preparación y alistamiento

1. Contar con un Plan de Contingencia para SMV aprobado y conocido por el personal clave.
2. Tener el espacio físico (COE) equipado con sistemas de comunicación, donde se instale el Puesto de Mando (PM), el Comité de Emergencias o el mecanismo organizacional definido por el establecimiento.
3. Definir su rol dentro de la RISS: unidad de choque, insignia y/o apoyo, de acuerdo con su capacidad resolutiva.
4. Para el alistamiento operativo (poner disponible lo preparado):

a) disponer de:

- Directorio interno actualizado y enlaces a CRUM, CVOED, Protección Civil, listado de establecimientos de apoyo, transportes, entre otros.
- Inventario de recursos críticos (camas, UCI, quirófanos, ventiladores, ambulancias, banco de sangre, imagenología, EPP, medicamentos clave, insumos) con autonomía mínima de 72 horas.
- Áreas de expansión internas y externas identificadas, incluyendo capacidad máxima de reconversión (número de camas adicionales por área).
- Convenios actualizados con cadenas de suministro externas para insumos clave, con planes que garantice una dotación extraordinaria en casos de arribo de múltiples víctimas.

b) Tener planeadas y señalizadas:

- Área de triage hospitalario (externa o en vestíbulo, evitando ingreso directo a urgencias).
- Dejar establecida el área para cadáveres (área negra)
- Áreas para pacientes rojos y amarillos. Los pacientes verdes se envían a otra unidad de menor capacidad resolutiva (descompresión).
- Áreas de expansión en espacios no clínicos (aulas, auditorios, salas de espera, estacionamientos techados).

c) Mantener personal entrenado en:

- SCI-H.
- Triage en SMV.
- Soporte vital avanzado (trauma, cardiovascular, pediátrico).
- Protocolos para emergencias por eventos QBRNE (cuando aplique).
- Protocolos específicos para eventos QBRNE, incluyendo descontaminación y EPP especializado, basado en guías de la OMS

3.2 Criterios operacionales de activación

El Plan de contingencia de SMV se activará cuando ocurra al menos una de las siguientes condiciones:

- Incidente con SMV en el área de influencia del hospital, confirmado por una fuente confiable (CRUM, CENACOM, CENAPRED, Protección Civil, autoridades de salud, CVOED).
- Requerimiento formal a la unidad por parte de una autoridad (sector salud, CRUM, protección civil u otras instancias) para la recepción de múltiples víctimas derivadas de un mismo evento.

- Arribo espontáneo y simultáneo de múltiples pacientes graves derivados de un mismo evento adverso, aun sin notificación previa, que supera la capacidad de gestión habitual del servicio de urgencias.

La activación se hará mediante un código interno predefinido (Por ejemplo, Código Naranja) y seguirá el esquema de alertas escalonadas establecido (por ejemplo: verde, amarilla, roja), descrito en el PH-RED.

3.3 Actividades durante la respuesta

1. Activación y ejecución de las funciones establecidas en el Plan de contingencia de SMV en concordancia con el SCI-H/Comité de Emergencias.
2. Organización interna del hospital en modo SMV:
   - Redistribución de personal,
   - Suspensión de actividades electivas,
   - Expansión y habilitación de los espacios físicos.
3. Organización para la coordinación externa:
   - Noria de ambulancias.
   - Triage hospitalario externo.
   - Sectores de atención por nivel de gravedad.
   - Comunicación permanente con CRUM / COE / CVOED.
   - Comunicación con otras unidades de la RISS para referencia y contra referencia.
   - Apoyo psicosocial en todas las áreas por primeros respondientes para afectados y personal sanitario.

3.4 Actividades para la fase de recuperación y restablecimiento de las funciones operativas habituales

- Desescalamiento progresivo de áreas de SMV conforme disminuye el arribo de víctimas.
- Reorganización de servicios para retomar actividad ordinaria y resolver el rezago asistencial.
- Evaluación de daños y rezagos en las atenciones, procedimientos, estudios diagnósticos, interconsultas e intervenciones quirúrgicas.
- Elaboración de informe post evento y actualización del plan.
- Seguimiento en acciones de salud mental por personal experto.

4. Plan de contingencia de SMV

Paso 1. Recepción de la alerta y diagnóstico inicial del incidente

- Fuentes posibles: CRUM, CVOED, COE estatal, Protección Civil, sistemas de emergencia, fuerzas de seguridad, otras unidades de salud, medios oficiales, arribo espontáneo masivo de víctimas.
- Registrar en formato de diagnóstico inicial:
    - Fecha y hora.
    - Nombre y cargo de quien recibe la alerta.
    - Fuente de información.
    - Tipo de incidente (sismo, accidente de transporte, incendio, colapso estructural, explosión, QBRNE, fenómeno hidrometeorológico, violencia, entre otros.).
    - Lugar del incidente.
    - Número aproximado de víctimas, gravedad estimada y posibles tiempos de arribo.
- Notificar de inmediato al Director(a) o autoridad máxima presente, y al CVOED por los medios establecidos (plataforma, teléfono, mensajería).

Paso 2. Declaratoria de SMV y activación del Plan de Contingencia

- El Director(a) del hospital o su suplente declara la activación del Código SMV (verde/amarillo/rojo según magnitud).
- Convoca al Comité de Emergencias y Desastres / establece el PM hospitalario.
- Activa el SCI-H.
- Notifica la activación del Plan de Contingencia al CRUM, CVOED y autoridades competentes, informando tipo de incidente, capacidad instalada y recursos disponibles.

Paso 3. Seguridad física del establecimiento

- Control de accesos: cerrar entradas secundarias y concentrar entradas/salidas en puntos controlados.
- Coordinar con seguridad interna y fuerzas de seguridad externas para:
    - Acordonar áreas críticas.
    - Controlar el ingreso de personas, vehículos y paquetes.
    - Garantizar rutas libres para ambulancias y evacuaciones.
- En caso de eventos con riesgo estructural o QBRNE:
    - Coordinar con Protección Civil y especialistas para valoración estructural
    - Activar protocolo de descontaminación.
    - Definir zonas seguras y no seguras dentro del hospital.
    - Activar protocolo de evacuación en caso necesario.

Paso 4. Expansión de capacidades y reconversión

- Suspender actividades no críticas, entre ellas:
  - Cirugía electiva.
  - Consulta externa.
  - Estudios diagnósticos programados.
- Desocupar áreas críticas:
- Urgencias, UCI, quirófanos, hemodiálisis, entre otros, mediante altas tempranas seguras o referencias a unidades de apoyo.
- Egresar a pacientes hospitalizados que no requieran continuidad inmediata o referirlos a unidades de menor complejidad.
- Concentrar pacientes que no pueden ser dados de alta en áreas definidas para facilitar su atención con equipos reducidos, de acuerdo con su estado de gravedad.
- Habilitar áreas de expansión:
  - Internas: salas de espera, consulta externa, áreas administrativas reconvertidas.
  - Externas: carpas, módulos temporales, estacionamientos techados, etc. Considerar espacios destinados a la atención psicosocial y contención emocional de víctimas y familiares, de ser posible, separados de las áreas hospitalarias o de urgencias.

Paso 5. Noria de ambulancias

- Habilitar la noria de ambulancias según lo previsto en el plan: circuito unidireccional con:
  - Punto de entrada.
  - Área de maniobras y desembarque.
  - Área de espera y reabastecimiento.
  - Punto de salida.
- Designar un oficial de transportes responsable de:
  - Coordinar el arribo y salida de ambulancias.
  - Priorizar la recepción de pacientes más graves.
  - Mantener comunicación con el CRUM y el PM.

Paso 6. Triage y atención hospitalaria de acuerdo con el nivel de gravedad

- Instalar el área de triage hospitalario en un sitio definido (idealmente externo o en vestíbulo):
  - Designar Oficial(es) de triage.
  - Organizar el flujo de pacientes que llegan en ambulancia y por sus propios medios.

    - Realizar triage rápido, reclasificación respecto al triage prehospitalario y derivación a sectores correspondientes.

- Organizar sectores de atención según triage (adaptar a la escala institucional):
    - Área roja: pacientes críticos / emergencia vital inmediata o que requieren monitorización estrecha.
    - Área amarilla: urgencias moderadas, susceptibles de reevaluación y derivación.
    - Área verde: urgencias leves
    - Área negra: pacientes fallecidos o en agonía no rescatable, con énfasis en cuidados paliativos y apoyo a familiares.
- Asignar binomios médico-enfermería a cada paciente rojo/amarillo en función de la gravedad y del rol de la unidad médica.
- Garantizar el soporte de áreas de apoyo:
    - Laboratorio, imagenología, banco de sangre.
    - Ingeniería biomédica, Trabajo social, psicología, nutrición.
    - Camillería, mantenimiento, higiene y limpieza.

Paso 7. Coordinación en la RISS y referencia–contrarreferencia

- El PM, en coordinación con el CRUM (CVOED)/COE, definirá:
    - Unidades Médicas de apoyo para derivar pacientes.
    - Criterios de referencia hacia unidades de mayor/menor complejidad.
- Implementar un centro coordinador/regulador de pacientes en el hospital de choque o insignia (según contexto), que:
    - Reciba información actualizada de capacidad en otros establecimientos.
    - Organice los traslados secundarios y terciarios.

Paso 8. Comunicación interna, externa y con la comunidad

- Designar un Oficial de comunicaciones responsable de:
    - Mantener comunicación con PM, CRUM, CVOED y otras autoridades.
    - Coordinar la información institucional con la oficina de Comunicación Social del IMSS.
- Establecer un punto de información a familiares en zona segura, con:
    - Listados nominales actualizados de víctimas.
    - Espacio para entrevistas clínicas y psicosociales.
- Definir un vocero único (idealmente la máxima autoridad del hospital) para medios de comunicación, con mensajes validados y coherentes con la operación hospitalaria.

Paso 9. Intervenciones en salud mental y bienestar del personal

- Activar un equipo de apoyo psicológico para:
  - Pacientes y familiares.
  - Personal de salud.
- Implementar medidas básicas de autocuidado organizacional:
  - Relevos programados.
  - Áreas de descanso, hidratación y alimentación.
  - Mecanismos para identificar y retirar temporalmente del frente de atención a personal en crisis aguda.

Paso 10. Desactivación del plan y retorno progresivo a la normalidad

- La desactivación será escalonada, guiada por el Comité del establecimiento, considerando:
  - Cese del arribo de nuevas víctimas.
  - Estabilización de la ocupación hospitalaria.
- Cierre paulatino de:
  - Noria de ambulancias y triage externo.
  - Sectores de expansión.
- Reordenamiento de:
  - Hospitalización, UCI y quirófanos.
  - Agenda de servicios programados (reincorporación gradual de cirugías electivas y consulta externa).
- Realizar:
  - Evaluación de daños y rezagos y rezagos en las atenciones, procedimientos, estudios diagnósticos, interconsultas e intervenciones quirúrgicas.
  - Informe posterior al evento
  - Revisión y actualización del Plan SMV y de esta guía operativa.

5. Anexos

Anexo 1. Grado de activación de recursos ante un SMV

Grado III	**La emergencia involucra al hospital de manera total y requiere apoyo externo para la respuesta al evento.**	▪ Se inicia la atención de víctimas de acuerdo con la demanda máxima de servicios que requiera la situación, con el hospital operando en modo de máxima capacidad. ▪ Se estudian y resuelven de forma prioritaria las solicitudes de insumos, reforzamiento de personal y apoyo técnico en las áreas críticas (urgencias, UCI, quirófanos, imagen, banco de sangre, etc.). ▪ Se efectúan acciones intensivas de contingencia, logística y gestión administrativa, así como de coordinación interna y externa con autoridades de salud, Protección Civil, CRUM, CVOED y otros hospitales de la red. ▪ Se verifican y ajustan continuamente las condiciones de operación de todas las áreas y equipos de respuesta, evaluando su desempeño hasta el final de la alerta. ▪ Se activa el máximo nivel de referencia/contrarreferencia y redistribución de pacientes, utilizando plenamente la RISS. ▪ Se evalúa y solicita la necesidad de apoyo externo a máximo nivel (recursos humanos adicionales, insumos, equipos, apoyo de otras instituciones del sector salud u otros sectores).
Grado II	**La emergencia involucra al hospital de manera total en la respuesta al evento.**	▪ Se inicia una vez que se establece la demanda de asistencia a raíz del evento y se confirma la necesidad de atención de múltiples víctimas. ▪ El hospital dispone y activa los recursos, áreas y personal de refuerzo requeridos para responder al SMV. ▪ Se implementan acciones de expansión de capacidad: reconversión de áreas, habilitación de zonas de expansión, reorganización de camas y servicios. ▪ Se reprograman o difieren procedimientos de baja complejidad y actividades electivas para priorizar la atención de lesionados. ▪ Se dan de alta pacientes seleccionados (altas tempranas seguras) para liberar camas en áreas críticas. ▪ Se activan formalmente los procedimientos de referencia y contrarreferencia, en coordinación con la red de hospitales de apoyo. ▪ Puede ir precedida de Alerta Verde o iniciarse directamente cuando la magnitud del evento así lo amerite.
Grado I	**La emergencia involucra al hospital de manera parcial en la respuesta al evento.**	▪ El hospital se organiza para atender una emergencia con el personal que está de servicio. ▪ Se contacta al personal emergente para que esté atento al llamado, pero aún no se les requiere presencia física inmediata. ▪ Se convoca a todo el personal a estar localizable y, según criterios locales, a hacer presencia física progresiva en el hospital. ▪ La organización cuenta con todos los recursos existentes, pero todavía no se ha iniciado la atención de un número significativo de afectados. ▪ Se verifican y estiman las reservas de los elementos indispensables para la asistencia (insumos médico-quirúrgicos, agua potable, combustible, suministros en general), determinando la capacidad y autonomía frente a la situación prevista. ▪ Se realiza revisión rápida del plan de contingencia SMV, áreas de expansión y circuitos (noria, triage, sectores), para estar en posibilidad de escalar a Alerta Amarilla.

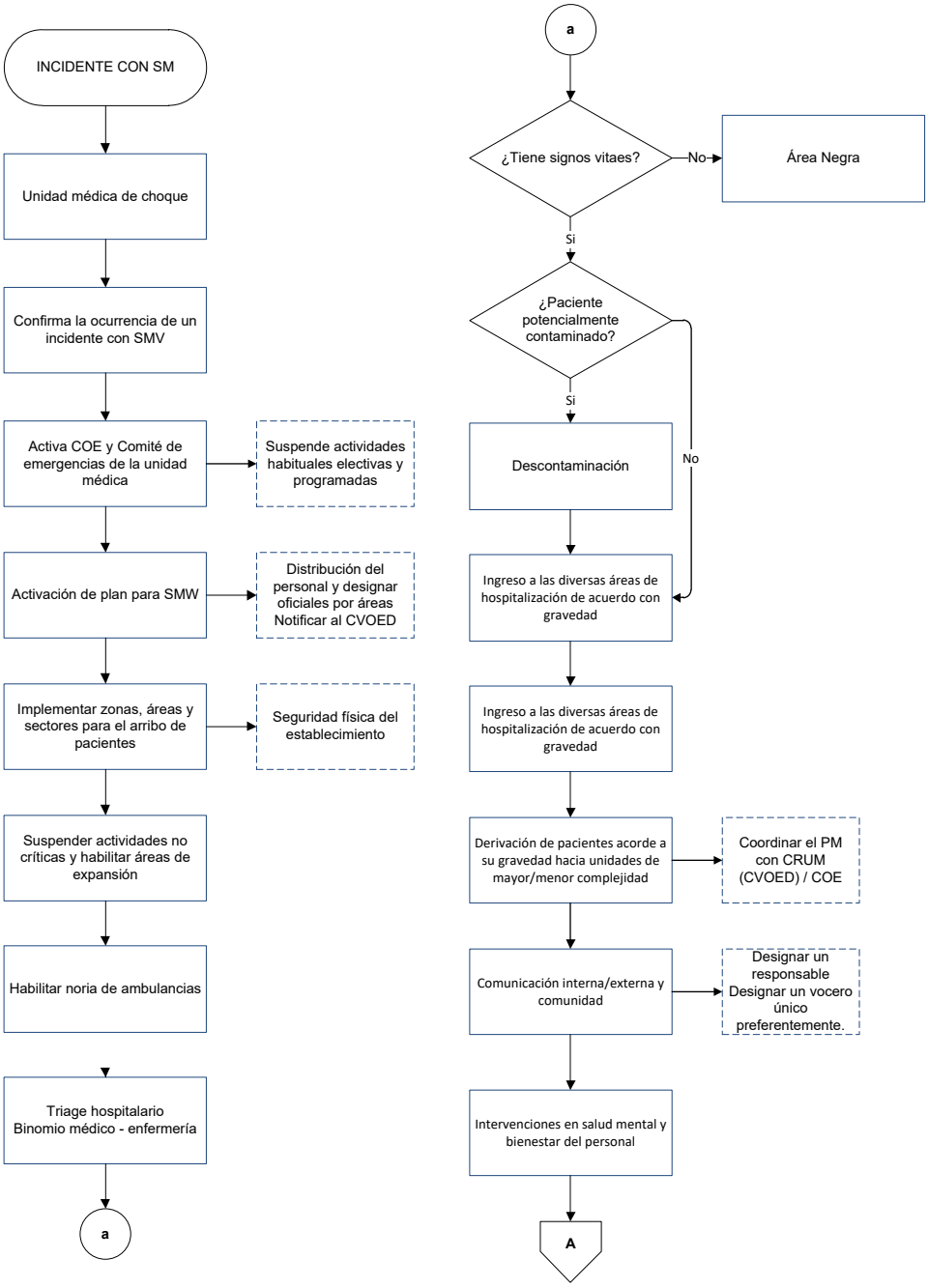
Anexo 2. Listado de establecimientos de apoyo (RISS)

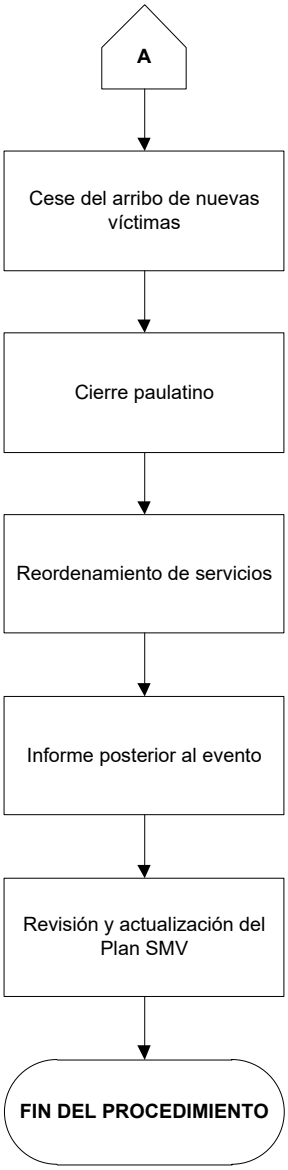
Nombre del establecimiento	Nivel de atención	Institución	Teléfono de contacto	Distancia en Km	Responsable	Camas disponibles

Anexo 3. Identificación de áreas de expansión en el hospital

Triage Hospitalario	Ubicación de las áreas de expansión	Extensión (m^2)	Número de camas	Número de binomios Médico-Enfermera	Servicios esenciales			
					Agua Potable	Energía Eléctrica	Gases medicinales O2, aire, succión)	Teléfono/ Internet
Triage					X	X		X
Área Roja					X	X	X	X
Área Amarilla					X	X	X	X
Area verde					X	X		X
Negra					X	X		

Anexo 4. Diagrama de flujo de la respuesta ante Saldo Masivo de Víctimas




A
Cese del arribo de nuevas víctimas
Cierre paulatino
Reordenamiento de servicios
Informe posterior al evento
Revisión y actualización del Plan SMV
FIN DEL PROCEDIMIENTO

Referencias

1. World Health Organization. Guide Mass casualty preparedness and response in emergency units. WHO [Internet]. 2022 [Consultado 01 de mayo 2024]. Disponible en: https://storage.googleapis.com/ncds-emergencies-2024-source/Background%20documents/Mass%20casualty%20preparedness%20and%20response%20in%20emergency%20units.%20Guide.%20Version%2020220501.pdf

2. Organización Panamericana de la Salud. Curso básico de Sistema de comando de incidentes para hospitales -SCIH-. OPS/OMS [Internet]. 2003 [Consultado 24 de julio 2024]. 24 de julio 2024). Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/644765/3.6_OPS_SCI_Hospitales__21.pdf

3. Rodríguez SA. Los Sistemas De Triage Ante Incidentes Con Múltiples Víctimas. PREHOSPITAL EMERGENCY CARE (ed. esp.). [Internet]. 2011 [Consultado 20 de mayo 2024]; 4 (1): 63-65. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-prehospital-emergency-care-edicion-espanola--44-articulo-los-sistemas-triage-ante-incidentes-X1888402411026624

4. Martín MS. Triage en situaciones de desastre. Cirujano General. [Internet]. 2010 [Consultado 10 de mayo 2024]; 32(1): S33-S36. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/cirgen/cg-2010/cge101m.pdf
5. Ponce RO, Diaz VS, Roman HC, Vinueza MC. El rol de la enfermería en el manejo de emergencias: desde el triage hasta la atención integral. JESSR. [Internet]. 2024 [Consultado 10 de mayo 2024]; 4(1):57-76. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/378771502_El_rol_de_la_enfermeria_en_el_manejo_de_emergencias_desde_el_triage_hasta_la_atencion_integral

6. Organización Panamericana de la Salud. La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equipos de respuesta. Segunda edición (revisada). OPS. [Internet]. 2016 [Consultado 11 de mayo 2024]. Disponible en: https://www3.paho.org/disasters/dmdocuments/Management-of-dead-bodies_Spa_2016.pdf

7. World Health Organization. Mass casualty management systems: strategies and guidelines for building health sector capacity. WHO [Internet]. 2007 [Consultado 01 de mayo 2024]. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789241596053

8. Organización Panamericana de la Salud. La salud mental en las situaciones de emergencia. [Internet]. 16 de marzo de 2022 [Consultado 13 mayo 2024]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-emergencies

9. World Health Organization. Mass casualty management systems: strategies and guidelines for building health sector capacity. OPS [Internet]. 2007 [Consultado 01 de mayo 2024]. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789241596053

10. Agency for Healthcare Research and Quality, U.S. Dept. of Health and Human Services. Altered Standards of Care in Mass Casualty Events. Agency for Healthcare Research and Quality, U.S. [Internet]. 2005 [Consultado 11 de mayo 2024]. Disponible en: https://openlibrary.org/books/OL3456082M/Altered_standards_of_care_in_mass_casualty_events

11. Echavarría ZS, Cruz VF, Elizondo AS, Martínez VE, et al. Atención en emergencias y desastres en las unidades de terapia intensiva del Instituto Mexicano del Seguro Social: triage y evacuación. Cir Cir [Internet]. 2013 [Consultado 01 de mayo 2024]; 81: 246-255. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/circir/cc-2013/cc133n.pdf

12. Organización Panamericana de la Salud. Establecimiento de un Sistema de Atención de Victimas en Masa. OPS [Internet]. 1996 [Consultado 13 de mayo 2024]. Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/778

13. Illescas FG. Triage: atención y selección de pacientes. TRAUMA [Internet]. 2006 [Consultado 12 de mayo 2024]; 9(2): 48-56. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/trauma/tm-2006/tm062e.pdf

14. Parellada BJ, Hidalgo SO. Plan para la recepción masiva de heridos y lesionados. Rev cubana Med Mil [Internet]. 2001 [Consultado 8 de mayo 2024]; 30(3): 166-171. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572001000300005

15. Klein Y, Klein M, Peleg K. ICU triage in terror-related mass casualty events. Critical Care [internet]. 2009 [Consultado el 24 de mayo de 2024]; 13(1): S186-S187. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/246089338_ICU_triage_in_terror-related_mass_casualty_events.

16. Peleg K. Disaster and emergency medicine – a conceptual introduction. Frontiers in Public Health [internet]. 2013 [Consultado el 24 de mayo de 2024]; 1(44): 1-2. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24350213/

17. Clarkson L, Williams M. EMS Mass Casualty Triage. StatPearls [Internet]. 2023 [Consultado el 8 de mayo de 2024]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459369/.

18. Carenzo L, Ingrassia PL, Foti F, Albergoni E, et.al. Region-Wide All-Hazard Training Program for Prehospital Mass Casualty Incident Management: A Real-World Case Study. Disaster

Med Public Health Prep [Internet]. 2022 [Consultado el 24 de mayo de 2024]; 17 (e184): 1-7. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35361292/

19. Brooke LE, Sxhwartz RB, McGovern JE. Emergency Medical Services: Clinical Practice and Sistems Oversight [Internet]. Wiley Online Library Third Edition; 2021.

20. Ledbury K, Glasgow S, Tallach R. Learning From Simulating Mass Casualty Events: A Systematic Search and a Comprehensive Qualitative Review. Disaster Med Public Health Prep [Internet]. 2022 [Consultado el 30 de mayo de 2024]; 17: e242. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36238998/

21. Gamberini L, Imbriaco G, Flauto A, Monesi A, et.al. Mass Casualty Management After a Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion in an Urban Area. J Emerg Med [Internet]. 2021 [Consultado el 30 de mayo de 2024];60(4):471-477. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33422372/

22. Tong JL. Mass casualty management. International Anesthesiology Clinics [Internet]. 2021 [Consultado el 30 de mayo de 2024]; 59(2): 67-72. Disponible en: https://journals.lww.com/anesthesiaclinics/Citation/2021/05920/Mass_casualty_management.9.aspx

23. Hugelius K, Becker J, Adolfsson A. Five challenges when managing mass casualty or disaster situations: a review study. Int. J. Environ. Res. Public Health [Internet]. 2020 [Consultado el 30 de mayo de 2024]; 17(9): 3068. Disponible en: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/9/3068

24. Secretaria de salud. Redes integradas de servicios de salud (RISS): Redes de atención. Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud [Internet]. 2020 [Consultado el 30 de octubre de 2024]. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/redes-integradas-de-servicios-de-salud-redes-de-atencion?state=published https://drive.google.com/file/d/1oDy8AXBzbyoMI2chmFPa8_fewiWtsqAF/view?pli=1

25. Organización Panamericana de la Salud. Hospitales en redes integradas de servicios de salud. Recomendaciones estratégicas. OPS [Internet] 2018. [Consultado el 07 de octubre de 2024]. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/hospitales-redes-integradas-servicios-salud-recomendaciones-estrategicas#:~:text=Mediante%20una%20revisi%C3%B3n%20de%20aspectos%20conceptuales%2C%20la%20descripci%C3%B3n,para%20transformar%20los%20hospitales%20en%20%E2%80%9Chospitales%20en%20red%E2%80%9D.

Recursos

Curso: Sistema de Comando de Incidentes para Hospitales (SCI-H). Campus Virtual de Salud Pública. OPS. Disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/sistema-de-comando-de-incidentes-para-establecimientos de salud.

Curso: Marco de respuesta multiamenaza: Planeamiento hospitalario para la respuesta a emergencias en salud y desastres. Campus Virtual de Salud Pública. OPS. Disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/respuesta-multiamenaza-planeamiento-hospitalario-emergencias

Curso: Curso virtual de evaluación de establecimientos de salud a través del índice de seguridad hospitalaria (ISHv2). Campus Virtual de Salud Pública. OPS. Disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/evaluacion-de-establecimientos-de-salud

Curso: Gestión de salud pública de los incidentes químicos. Prevención, planificación y preparación, detección y alerta, respuesta y recuperación. Disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/salud-incidentes-quimicos

Contacto

Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED)
(24/7 los 365 días del año)
Teléfonos:
55 52 62 53 68 (directo)
55 52 38 27 00 (conmutador), Extensiones: 19081, 19083, 10315, 19832 y 19831
55 80 03 58 24 (WhatsApp)
Sitio web: https://cvoed.imss.gob.mx
Correo electrónico: cvoed.coord@imss.gob.mx

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS)
55 5095 3200 línea nacional para reportes relacionados con fuentes radiactivas robadas o emergencias radiológicas.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
55 11 03 60 00 ext. 72034

Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil / Sistema Nacional de Protección Civil (CENACOM), 24 horas 365 días del año
51 28 00 00 ext. 36422 y 36428